EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90892
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2024-08-19 11:19:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARCELINO FLORIDOR ANDRADES GUAJARDO			RUN	: 4.729.833-4
F.Nac	: 21-07-2024	Edad	: 0 AÑO	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-06	Fecha Egreso	: 2024-08-19 11:19:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. T95.3-SECUELAS DE QUEMADURA, CORROSION Y CONGELAM. DE MIEMBRO INFE

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. ACV isquémico capsular derecho (05.08.24)
2. Estenosis ACI derecha >70% sintomática
3. (2) ACV no secuelados en territorio ACI derecha (21.07.24) /frontal y parietal derechos
4. Quemadura por agua caliente pierna izquierda no infectada en curación avanzada
5. FA paroxística en TACO reciente
6. HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. L55.1-QUEMADURA SOLAR DE SEGUNDO GRADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I69.3-SECUELAS DE INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I48.0-FIBRILACION AURICULAR PAROXISTICA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes descritos, hospitalizado el 05.08.24 derivado a cirugía para manejo avanzado de herida en pierna izquierda con mal manejo ambulatorio, mientras se encontraba en urgencias presenta paresia severa braquial izquierda (previo ingreso sin focalidad neurológica), se realiza TC cerebro que muestra hipodensidad aguda capsular posterior derecha, hipodensidad secuelar limítrofe ACM/ACP derecha, se indica ajustar doble AA (aspirina + cilostazol), se rescata informe de holter de ritmo 30.07.24 que informa FA paroxísitca, se inicia anticoagulación con enoxaparina sin incidentes, paciente evoluciona favorablemente de herida, sin signos infección, no requiere aseo quirúrgico, se indica alta por cirugía en espera de resolución por cirugía vascular para endarterectomía carotídea derecha (caso discutido con jefatura de Cx HSC y Dra. Urdaneta HCHM). Por estabilidad clínica indico HODOM, ajusto anticoagulación, en caso de programar cirugía, suspender dabigatrán 48 horas antes.}
** pase cardiológico otorgado
** pase anestesia otorgado pero no como cirugía de urgencia

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO EN DOMICILIO, LEVANTAR ASISTIDO CON SILLA O ANDADOR
2. REGIMEN LIVIANO HIPOSODICO
3. DABIGATRAN 110 MG VO C/12 HRS

4. ATORVASTATINA 80 MG VO DIA
5. CARVEDILOL 6,25 MG VO DIA
6. QUETIAPINA 25 MG 1/2 O 1 NOCHE SOS
7. ACIDO ASCORBICO 500 MG 2-0-2
8. METAMIZOL 300 MG VO EN CASO DOLOR
9. PARACETAMOL 1 GR VO EN CASO DOLOR
10. HOSPITALIZACION DOMICILIARIA (CURACIÓN HERIDA PIERNA IZQUIERDA + KINE MOTORA)
11. CONTROL AMBULATORIO POLI NEUROLOGIA -> SOLICITAR POR HODOM AL ALTA
12. EN CASO PROGRAMAR CIRUGIA CAROTIDEA, SUSPENDER DABIGATRAN 2 DÍAS ANTES

EXÁMENES Y RESULTADOS

ecocardiograma 13.08.24: AI 45 mm, FEVI 59%, AI severamente dilatada, insuficiencia mitral leve, resto sin alteraciones significativas
holter de ritmo 30.07.24: FA paroxística
laboratorio 05.08.24: crea 0,9, PCR 9,5, na+ 141, k+, 4, cl- 104, uremia 44, hto 35,3%, leucocitos 9000, plaquetas 346.000
(2)TC cerebro

NATALIA BEATRIZ HERNANDEZ LAGOS
MEDICO TRATANTE
15877858-0

JEFE SERVICIO